

## Зняття шкірних швів

**Сценарій.** У хірургічному відділенні знаходиться пацієнт 7 добу після апендектомії. Післяопераційна рана загоюється первинним натягом. Треба провести процедуру- зняття шкірних швів.

перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

| № п/п | Перелік медичного обладнання | Кількість |
|-------|------------------------------|-----------|
| 1     | Хірургічні ножиці            | 1 шт.     |
| 2     | Хірургічний пінцет           | 1 шт.     |
| 3     | Хірургічний лоток            | 2 шт      |

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

| № п/п | Перелік медичного обладнання                       | Кількість на 1 спробу | Кількість на 10 спроб |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Марлеві кульки для обробки шкіри операційного поля | 2 шт                  | 20 шт                 |
| 2     | Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту) | 10 мл                 | 100 мл                |
| 3     | Медичні стерильні рукавички                        | 1 пара                | 10 пар                |
| 4     | Асептична пов'язка                                 | 1 шт                  | 10 шт                 |
| 5     | Захисна медична маска                              | 1 шт                  | 10 шт                 |

| № | Маніпуляція                                                                                                                              | Форма представлення |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Коректне розташування лікар-пацієнт, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)                 | Сказати             |
| 2 | Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій                                                                      | Сказати             |
| 3 | Обробити руки хірургічним способом (лікар в рукавичках), надіти стерильний одяг, окуляри                                                 | Виконати            |
| 4 | Зняти пов'язку, виконати огляд рани, визначити кількість швів, які будуть зніматися                                                      | Виконати/ Сказати   |
| 5 | Коректно обробити місце швів розчином антисептику (широко марлевою серветкою у пінцеті, другою марлевою серветкою у пінцеті)             | Сказати             |
| 6 | Коректно виконати зняття швів:<br>- вузол шва захопити пінцетом і трохи підняти<br>- нитку, що з'явилася над шкірою, перерізати ножицями | Виконати/ Сказати   |

|   |                                                                                                                            |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | - без зусилля витягнути кінчик нитки із вузлом, шов злегка відтягнути пінцетом<br>- перевірити цілісність шкірних покривів |          |
| 7 | Обробити рану антисептиком                                                                                                 | Сказати  |
| 8 | Накрити поверхню рани стерильною серветкою, зафіксувати лейкопластиром                                                     | Виконати |
| 9 | Уточнити у пацієнта його самопочуття                                                                                       | Сказати  |

## Діагностика

### 3.1. Діагностика якості загоєння рани (первинним натягом)

**Сказати:** «Оцінюю стан післяопераційної рани: краї рани зімкнуті, відсутні ознаки інфільтрації, гіперемії, серозних або гнійних виділень. Рана загоїлася первинним натягом.»

### 3.2. Діагностика відсутності ускладнень (набряк, нагноєння)

**Сказати:** «Ознак нагноєння або запалення не виявлено: температура шкіри над ранною в

нормі, набряку немає, виділень немає. Це свідчить про відсутність післяопераційних

ускладнень.»

## 4. Визначення тактики ведення та лікування

### 4.1. Визначення необхідності призначення медикаментозної терапії

**Сказати:** «З урахуванням загального стану пацієнта, наявності симптомів, що можуть свідчити про тимчасовий парез кишечника, рекомендую продовження підтримувальної терапії:

- дезінтоксикаційна інфузія;
- спазмолітики за потреби;
- контроль рівня глюкози крові, з огляду на можливий цукровий діабет;
- дієта за станом ШКТ;
- моніторинг загального стану.»

### 4.2. Визначення необхідності призначення фізіотерапії

**Сказати:** «З урахуванням відсутності ускладнень, можна рекомендувати фізіотерапевтичні заходи для покращення трофіки тканин і профілактики спайкових

процесів — наприклад, УВЧ або магнітотерапію в післяопераційній зоні, за відсутності

протипоказів.»

Завершення маніпуляції

**Сказати й виконати:**«Після обробки шкіри антисептиком знімаю шви стерильними

інструментами. Накладаю асептичну пов'язку. Як ваше самопочуття? Є дискомфорт або

біль?»

«Умовно утилізую матеріал, знімаю рукавички, обробляю руки. Маніпуляцію завершено